

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DENTALTECH

QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÂM SÀNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

Số: 01/2026/QT-DENTALTECH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-DENTALTECH ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc DentalTech JSC)

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm Mặt;

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;

Giám đốc DentalTech JSC ban hành Quy trình vận hành lâm sàng và kiểm soát chất lượng nội bộ như sau:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định về checklist lâm sàng bắt buộc trước, trong và sau khi thực hiện thủ thuật răng hàm mặt; kiểm soát nhiễm khuẩn và vô khuẩn dụng cụ; yêu cầu hồ sơ bệnh án và an toàn người bệnh; quy trình bàn giao ca giữa các bộ phận và theo dõi tái khám tại DentalTech JSC.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với toàn bộ bác sĩ, trợ thủ nha khoa, lễ tân, điều dưỡng và nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn đang làm việc tại các cơ sở của DentalTech JSC.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thủ thuật là bất kỳ can thiệp lâm sàng nào lên răng, nướu, xương hàm hoặc mô mềm khoang miệng của người bệnh.
2. Checklist bắt buộc là danh mục các bước phải được xác nhận hoàn thành trước khi chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình điều trị.

3. Bàn giao ca là việc chuyển giao thông tin và trách nhiệm chăm sóc người bệnh giữa hai nhân sự hoặc hai bộ phận liên tiếp trong cùng một ca điều trị.

Chương II

CHECKLIST LÂM SÀNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU THỦ THUẬT

(áp dụng theo cấu trúc quy trình kỹ thuật ban hành tại Quyết định số 2121/QĐ-BYT)

Mục 1

CHUẨN BỊ TRƯỚC THỦ THUẬT

Điều 4. Khai thác bệnh sử và tiền sử dị ứng

1. Trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào, người hành nghề phải khai thác đầy đủ bệnh sử toàn thân và tiền sử dị ứng thuốc, dị ứng vật liệu nha khoa của người bệnh.
2. Trường hợp người bệnh có tiền sử dị ứng đã ghi nhận trong hồ sơ, người hành nghề phải đối chiếu tiền sử này với thuốc, vật liệu dự kiến sử dụng trước khi kê đơn hoặc chỉ định.
3. Nếu phát hiện nguy cơ dị ứng chéo, người hành nghề phải tạm dừng thủ thuật và hội chẩn trước khi tiếp tục.

Điều 5. Đo và ghi nhận sinh hiệu

1. Sinh hiệu bao gồm mạch, huyết áp, nhiệt độ phải được đo và ghi nhận vào hồ sơ trước khi thực hiện thủ thuật xâm lấn.
2. Trường hợp sinh hiệu bất thường, người hành nghề phải hội chẩn với bác sĩ phụ trách trước khi tiến hành thủ thuật.

Điều 6. Chỉ định và chống chỉ định

1. Người hành nghề phải xác nhận thủ thuật dự kiến thuộc chỉ định phù hợp với tình trạng người bệnh theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
2. Người hành nghề phải loại trừ các chống chỉ định đã được quy định cho từng loại thủ thuật trước khi tiến hành.

Điều 7. Chẩn đoán hình ảnh bắt buộc trước can thiệp

1. Đối với các thủ thuật can thiệp xương hoặc cấy ghép implant, phải có phim chẩn đoán hình ảnh được chụp trong thời hạn hợp lệ theo quy định chuyên môn trước khi tiến hành.
2. Phim chẩn đoán hình ảnh phải được lưu trong hồ sơ bệnh án của người bệnh.

Mục 2

TRONG QUÁ TRÌNH THỦ THUẬT

Điều 8. Xác nhận đồng ý của người bệnh

1. Phải có giấy đồng ý, có chữ ký của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp, trước khi bắt đầu bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào.
2. Trường hợp chưa có giấy đồng ý hợp lệ, người hành nghề không được phép bắt đầu thủ thuật.

Điều 9. Ghi nhận các bước tiến hành

1. Mọi bước tiến hành của thủ thuật phải được ghi nhận vào hồ sơ bệnh án ngay trong hoặc ngay sau khi hoàn thành, bao gồm vật liệu sử dụng, liều lượng thuốc tê, thời gian bắt đầu và kết thúc.

Mục 3

SAU THỦ THUẬT

Điều 10. Theo dõi và xử trí tai biến

1. Người bệnh phải được theo dõi tại chỗ tối thiểu mười lăm phút sau thủ thuật có gây tê để phát hiện sớm tai biến.
2. Mọi tai biến phát sinh phải được ghi nhận vào hồ sơ và báo cáo theo quy trình an toàn người bệnh quy định tại Chương IV của Quy trình này.

Điều 11. Hướng dẫn chăm sóc sau điều trị

1. Người hành nghề phải cung cấp hướng dẫn chăm sóc sau điều trị bằng văn bản cho người bệnh trước khi rời cơ sở.
2. Hướng dẫn phải bao gồm dấu hiệu bất thường cần tái khám ngay, cách chăm sóc vết thương, chế độ ăn uống phù hợp.

Chương III

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ VÔ KHUẨN DỤNG CỤ

(áp dụng theo Thông tư số 16/2018/TT-BYT)

Điều 12. Phân công người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Mỗi cơ sở của DentalTech JSC phải có tối thiểu một người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn, đã hoàn thành khóa đào tạo tối thiểu năm ngày về kiểm soát nhiễm khuẩn.
2. Giám đốc cơ sở chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ

sở.

Điều 13. Vệ sinh tay và phòng hộ cá nhân

1. Người hành nghề phải thực hiện vệ sinh tay trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh theo đúng quy trình rửa tay chuẩn.
2. Người hành nghề phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân bao gồm găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ phù hợp với từng loại thủ thuật.

Điều 14. Xử lý và tiệt khuẩn dụng cụ tái sử dụng

1. Dụng cụ nha khoa tái sử dụng phải được khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung, bảo đảm an toàn và chất lượng trước khi dùng cho người bệnh tiếp theo.
2. Không được sử dụng dụng cụ chưa hoàn tất quy trình tiệt khuẩn cho bất kỳ người bệnh nào.
3. Việc vệ sinh môi trường bề mặt, nước, không khí tại phòng thủ thuật phải tuân theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Chương IV

HỒ SƠ BỆNH ÁN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

(áp dụng theo các tiêu chí C2.1, C2.2, D2.1 đến D2.5 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành tại Quyết định số 6858/QĐ-BYT)

Điều 15. Yêu cầu đầy đủ hồ sơ bệnh án

1. Hồ sơ bệnh án của mỗi người bệnh phải được lập đầy đủ, chính xác ngay trong quá trình khám và điều trị, bao gồm tối thiểu thông tin hành chính, bệnh sử, khám lâm sàng, chẩn đoán, kế hoạch điều trị, giấy đồng ý, các bước đã tiến hành, đơn thuốc và hướng dẫn sau điều trị.
2. Hồ sơ bệnh án thiếu bất kỳ mục nào tại khoản 1 Điều này được coi là hồ sơ không đầy đủ và phải được bổ sung trước khi đóng ca điều trị.

Điều 16. Xác định đúng người bệnh

1. Người hành nghề phải xác định đúng danh tính người bệnh gồm họ tên và ngày sinh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên người bệnh.

Điều 17. Báo cáo sự cố y khoa

1. Mọi sự cố y khoa hoặc tai biến phát sinh trong quá trình điều trị phải được báo cáo cho người phụ trách chất lượng trong vòng hai mươi bốn giờ.

2. DentalTech JSC phải xây dựng và duy trì hệ thống ghi nhận, phân tích sự cố y khoa để phòng ngừa tái diễn.

Chương V

BÀN GIAO CA VÀ THEO DÕI TÁI KHÁM

(áp dụng theo tiêu chí C6.2, D3.3 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; các nội dung khác do DentalTech JSC tự quy định phù hợp với mô hình vận hành phòng khám)

Điều 18. Bàn giao giữa lễ tân, trợ thủ và bác sĩ

1. Lễ tân phải bàn giao đầy đủ thông tin lịch hẹn, lý do khám và tình trạng bảo hiểm của người bệnh cho trợ thủ trước khi người bệnh vào phòng điều trị.
2. Trợ thủ phải bàn giao cho bác sĩ điều trị các thông tin đã chuẩn bị gồm hồ sơ, phim chẩn đoán hình ảnh nếu có, kết quả đo sinh hiệu.
3. Mọi bàn giao phải được xác nhận bằng cách đánh dấu hoàn thành trên hệ thống quản lý ca bệnh, không được bàn giao chỉ bằng lời nói mà không ghi nhận.

Điều 19. Bàn giao khi thay đổi người phụ trách điều trị

1. Trường hợp người bệnh được chuyển từ bác sĩ này sang bác sĩ khác trong cùng một liệu trình điều trị, bác sĩ bàn giao phải ghi chú tóm tắt tình trạng điều trị, các bước đã hoàn thành và kế hoạch tiếp theo vào hồ sơ bệnh án.

Điều 20. Lịch hẹn tái khám

1. Đối với các thủ thuật có yêu cầu theo dõi sau điều trị theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành, DentalTech JSC phải đặt lịch tái khám cho người bệnh trước khi người bệnh rời cơ sở.
2. Lịch tái khám phải được ghi nhận vào hồ sơ bệnh án và hệ thống nhắc lịch của phòng khám.

Điều 21. Theo dõi sau điều trị

1. Trường hợp người bệnh không đến tái khám đúng lịch hẹn, lễ tân phải liên hệ nhắc lịch trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày hẹn.
2. Trường hợp không liên hệ được người bệnh sau hai lần nhắc lịch, phải ghi nhận vào hồ sơ và báo cáo cho người phụ trách chất lượng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng thống nhất tại toàn bộ các cơ sở của DentalTech JSC.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Trưởng các bộ phận, toàn thể bác sĩ, trợ thủ, lễ tân và nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn tại DentalTech JSC chịu trách nhiệm thi hành Quy trình này.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các cơ sở trực thuộc;
- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Ghi chú: Đây là văn bản nội bộ do DentalTech JSC (công ty giả định) tự soạn dựa trên Quyết định 2121/QĐ-BYT, Thông tư 16/2018/TT-BYT và Quyết định 6858/QĐ-BYT của Bộ Y tế, phục vụ mục đích thử nghiệm sản phẩm tại Vietnam AI Innovation Challenge 2026, không phải văn bản pháp lý chính thức.